

TEMA 8 (I). Incapacidad temporal

► **ACTUALIZACIÓN 2026 · TEMA 8 (I) INCAPACIDAD TEMPORAL: sin cambios normativos respecto de 2025. El tema se mantiene vigente.**

ÍNDICE DEL TEMA

1. 1. INCAPACIDAD TEMPORAL: CONCEPTO Y CAUSAS QUE MOTIVAN ESTA
2. 2. BENEFICIARIOS
3. 3. PRESTACIÓN ECONÓMICA: DETERMINACIÓN Y CUANTÍA
4. 3.1. BASE REGULADORA
5. 3.2. PORCENTAJE
6. 4. NACIMIENTO, DURACIÓN Y EXTINCIÓN DEL DERECHO
7. 4.1. NACIMIENTO
8. 4.2. DURACIÓN
9. 4.3. EXTINCIÓN DEL DERECHO
10. 4.4. PÉRDIDA O SUSPENSIÓN DEL DERECHO AL SUBSIDIO
11. 5. RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PRESTACIÓN
12. 5.1. RESPONSABILIDAD DEL PAGO
13. 5.2. PAGO DELEGADO O COLABORACIÓN OBLIGATORIA DE LAS EMPRESAS
14. 6. EL CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL
15. 6.1. COMPETENCIAS
16. 6.2. GESTIÓN DE LAS BAJAS, CONFIRMACIÓN, INFORMES COMPLEMENTARIOS Y DE

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE TEMA?

La IT es una de las prestaciones más frecuentes y más preguntadas. Los porcentajes según tramos (60% hasta día 20, 75% desde el 21), quién paga cada tramo y la duración máxima (365+180 días) son datos que hay que tener automatizados. Atención a la diferencia entre CC y AT/EP.

Palabras clave: IT · Base Reguladora · 60%-75% · Pago delegado · 365 días · AT/EP · Contingencias Comunes

situación. Beneficiarios. Prestación económica: Determinación y cuantía. Nacimiento, duración y extinción del derecho al subsidio.

Reconocimiento y pago. Control de la incapacidad.

El régimen jurídico del subsidio por incapacidad temporal se contiene en las siguientes normas:

o Texto Refundido de la Ley general de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por el

Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre —entrada en vigor el 1 de enero de

2016—(arts. 169 a 176).

o Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento general de prestaciones económicas del régimen general de la Seguridad Social.

o Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del régimen general de la Seguridad Social.

o Real Decreto 1131 /2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial.

o Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de

Seguridad Social, en relación con la prestación de incapacidad temporal.

o Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración.

o Orden de 25 de noviembre de 1966, por la que se regula la colaboración de las empresas en la gestión del régimen general de la Seguridad Social.

o Orden de 13 de octubre de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de la prestación por incapacidad laboral transitoria en el régimen general de la Seguridad Social.

o Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto

625/2014, de 18 de Julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración.

1. INCAPACIDAD TEMPORAL: CONCEPTO Y CAUSAS QUE MOTIVAN ESTA

SITUACIÓN.

1. Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal:

a) Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación.

Tendrán la consideración de situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes aquellas en que pueda encontrarse la mujer en caso de menstruación incapacitante secundaria, así como la debida a la interrupción del embarazo, voluntaria o no, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de

Salud y esté impedida para el trabajo, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la interrupción del embarazo sea debida a accidente de trabajo o enfermedad profesional, en cuyo caso tendrá la consideración de situación de incapacidad temporal por contingencias profesionales.

Se considerará también situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes la de gestación de la mujer trabajadora desde el día primero de la semana trigésima novena.

Se considerará situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes aquella en la que se encuentre la persona trabajadora donante de órganos o tejidos para su trasplante. Esta situación comprenderá tanto los días discontinuos como ininterrumpidos, en los que el donante reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo como consecuencia de la preparación médica de la cirugía, como los transcurridos desde el día del ingreso hospitalario para la realización de

esta preparación o la realización del trasplante hasta que sea dado de alta por curación.

Solo tiene la consideración de incapacidad temporal tal situación durante un periodo máximo de 365 días, prorrogables por otros 180 días, cuando se presume que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación. Ello implica que, transcurrido el plazo máximo de 545 días naturales desde la baja médica, el subsidio que el beneficiario viniera percibiendo se extingue, sin perjuicio de la prolongación de sus efectos económicos en los supuestos que se examinan más adelante.

b) Los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración máxima de ciento ochenta días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

2. A efectos del período máximo de duración de la situación de incapacidad temporal que se señala en la letra a) del apartado anterior, y de su posible prórroga, se computarán los períodos de recaída y de observación.

Se considerará que existe recaída en un mismo proceso cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de efectos de alta médica anterior, salvo los procesos por bajas médicas por menstruación incapacitante secundaria en los que cada proceso se considerará nuevo sin computar a los efectos del período máximo de duración de la situación de incapacidad temporal, y de su posible prórroga.

2. BENEFICIARIOS

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 del TRLGSS, para ser beneficiario del subsidio es preciso acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Estar afiliado, en alta o situación asimilada al alta, como indica para todas las prestaciones el artículo 165.1 del TRLGSS, sin perjuicio del alta de pleno derecho en los supuestos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, aunque el empresario haya incumplido sus obligaciones, como mantiene el artículo 166.3 de la misma norma.

Se consideran situaciones asimiladas a la de alta:

- La percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo.
- Traslado por la empresa fuera del territorio nacional.
- Convenio especial de diputados y senadores de las Cortes Generales y diputados del Parlamento Europeo, y de gobernantes y parlamentarios de comunidades autónomas.
- La situación del trabajador durante el periodo correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas por el mismo con anterioridad a la finalización del contrato.

Una situación especial acontece cuando el trabajador ha ejercitado el derecho de huelga, ya que el artículo 173.3 del TRLGSS establece que durante las situaciones de huelga y cierre patronal el trabajador no tendrá derecho a la prestación económica por incapacidad temporal. Una vez finalizada la huelga se iniciará la prestación económica si la contingencia de IT nació durante la huelga; si surgió la IT antes de la huelga, esta situación no suspende la prestación económica de aquel que ya viniese percibiéndola.

Si la huelga es parcial, en cuanto que el trabajador efectúa actividad laboral durante parte de la jornada, podrá nacer la contingencia de IT durante el periodo de actividad.

2. Tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante, en caso de enfermedad común.

En las situaciones especiales previstas en el párrafo segundo y cuarto del artículo 169.1 a), no se exigirán periodos mínimos de cotización.

En la situación especial prevista en el párrafo tercero del artículo 169.1 a) se exigirá que la interesada acredite los periodos mínimos de cotización señalados en el artículo 178.1, según la edad que tenga cumplida en el momento de inicio del descanso.

No se exige periodo previo de cotización en caso de accidente, sea o no de trabajo, y de enfermedad profesional (art. 172 del TRLGSS).

Se ha de tener en cuenta:

— En caso de exigirse periodo mínimo de cotización, será computable la cotización por pagas extraordinarias (días cuota).

— Si el trabajador fuera responsable del ingreso de cotizaciones (en el Régimen

General en el caso de artistas y profesionales taurinos en los supuestos que se estudian en el tema correspondiente), para el reconocimiento del subsidio será necesario que se encuentre al corriente en el pago de las cotizaciones de la

Seguridad Social. En otro caso, y siempre que se acreditara el periodo mínimo de cotización exigible será de aplicación el mecanismo de invitación al pago (art. 47 del TRLGSS).

— En el caso de contratos de carácter temporal, de duración igual o inferior a 5 días, cada día cotizado se considerará como 1,4 días, sin que en ningún caso pueda computarse mensualmente un número de días mayor que el que corresponda al mes respectivo. (Art. 249 bis LGSS)

3. PRESTACIÓN ECONÓMICA: DETERMINACIÓN Y CUANTÍA

La prestación consiste en un subsidio cuya cuantía está en función de la base reguladora (BR) y de los porcentajes aplicables a la misma.

3.1. BASE REGULADORA a) Accidente no laboral y enfermedad común (contingencias comunes)

Es el resultado de dividir el importe de la base de cotización del trabajador en el mes anterior de la fecha de iniciación de la incapacidad por el número de días a que dicha cotización se refiere (este divisor será concretamente: 30, si el trabajador tiene salario mensual; 30; 28,29,30, 31, si tiene salario diario).

No obstante, si el trabajador ingresa en la empresa en el mismo mes en que se inicia la incapacidad, se tomara para la BR la base de cotización de dicho mes, dividida por los días efectivamente cotizados. También, se tomarán como divisor los días efectivamente cotizados, cuando el trabajador no ha permanecido en alta durante todo el mes natural anterior.

b) Accidente de trabajo y enfermedad profesional (contingencias profesionales). La BR se obtiene por adición de dos sumandos:

- La base de cotización por contingencias profesionales del mes anterior, sin horas extraordinarias, dividida por el número de días a que corresponda dicha cotización.

- La cotización por horas extraordinarias del año natural anterior, dividida entre 365 días.

c) En el caso de pluriempleo

Se calcula computando todas las bases de cotización en las distintas empresas con aplicación del tope máximo vigente a efectos de cotización.

d) En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la prestación de servicios

La base reguladora diaria de la prestación por incapacidad temporal será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización a tiempo parcial acreditadas desde la última alta, con un máximo de tres meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, entre el número de días naturales comprendidos en el período.

Para las personas con contrato fijo-discontinuo la base reguladora diaria de la prestación por incapacidad temporal será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas desde su alta en el correspondiente régimen a consecuencia del inicio de la prestación de servicios motivado por el último llamamiento, con un máximo de tres meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, entre el número de días naturales comprendidos en el período.

La prestación económica se abonará durante todos los días naturales en que la persona beneficiaria se encuentre en la situación de incapacidad temporal. (Art.

248.1 c) TRLGSS

3.2. PORCENTAJE

En caso de enfermedad común y accidente no laboral:

- 60% desde el día 4º hasta el 20º inclusive.
- 75% desde el día 21º en adelante.

En caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional el 75 % desde el día en que se produzca el nacimiento del derecho.

No obstante, en la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos para su trasplante, prevista en el párrafo cuarto del artículo 169, apartado 1, letra a), la prestación consistirá en un subsidio equivalente al cien por ciento de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

4. NACIMIENTO, DURACIÓN Y EXTINCIÓN DEL DERECHO

4.1. NACIMIENTO

El artículo 173 del TRLGSS y el artículo 8 de la Orden de 13 de octubre de 1967, distinguen el nacimiento del derecho según el riesgo del que derive la contingencia de IT:

A) Accidente no laboral y enfermedad común: el derecho nace a partir del 4.º día, a contar desde la fecha de la baja para el trabajo. En consecuencia, los 3 primeros días no se percibe prestación económica por dicha contingencia.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, entre el 4.º día y el 15.º día, el subsidio deberá ser abonado por la empresa y a su cargo. A partir del día 16º, la prestación corre a cargo de la entidad gestora o colaboradora (mutua colaboradora con la seguridad social) aunque el pago efectivo lo realiza la empresa en régimen de colaboración obligatoria (pago delegado, que se examinará más adelante).

Como se desprende de lo anterior, durante los tres primeros días de la baja médica, el trabajador no tiene derecho a prestación por incapacidad temporal. Pero hay que tener en cuenta que una gran parte de los convenios colectivos tienen establecido pactos en virtud de los cuales las empresas abonan el salario correspondiente a estos tres primeros días.

B) Accidente de trabajo y enfermedad profesional: el derecho nace desde el día siguiente al de la baja en el trabajo. El día de la baja será remunerado por el empresario, estando a su cargo el salario íntegro y a efectos de cotización se ingresará como día en activo.

C) En las situaciones especiales de incapacidad temporal por menstruación incapacitante secundaria y por donación de órganos o tejidos para su trasplante previstas en los párrafos segundo y cuarto del artículo 169.1 a), el subsidio se abonará a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes desde el mismo día de baja.

D) En la situación especial de incapacidad temporal por interrupción del embarazo prevista en el mismo párrafo segundo del artículo 169.1 a), así como en la situación especial de gestación desde el día primero de la semana trigésima novena de gestación, prevista en el párrafo tercero del mismo artículo, desde el día primero de la semana trigésima novena de gestación, prevista en el párrafo tercero del mismo artículo, el subsidio se abonará a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja.

E) No obstante, en la situación especial de incapacidad temporal a partir de la semana trigésima novena de gestación, el subsidio se abonará desde que se inicie la baja laboral hasta la fecha del parto, salvo que la trabajadora hubiera iniciado anteriormente una situación de riesgo durante el embarazo, supuesto en el cual permanecerá percibiendo la prestación correspondiente a dicha situación en tanto esta deba mantenerse.

4.2. DURACIÓN

a) Plazo de duración de 365 días. La situación de IT que derive de riesgos comunes o profesionales tiene una duración máxima de 365 días, y de forma excepcional se prorroga por otros 180 días más siempre y cuando se presuma que durante estos puede el beneficiario ser dado de alta médica por curación (169.1 del TRLGSS).

Hasta el cumplimiento del plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días de los procesos de incapacidad temporal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ejercerá, a través de su inspección médica, las mismas competencias que la

Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u órgano equivalente del respectivo servicio público de salud para emitir un alta médica a todos los efectos, así como para considerar que existe recaída en un mismo proceso, cuando se produzcan las circunstancias que se recogen en el último párrafo del apartado 2 del artículo anterior.

Cuando el alta haya sido expedida por el INSS, este será el único competente, a través de sus propios inspectores médicos, para emitir una nueva baja médica producida por la misma o similar patología en los 180 días siguientes a la citada alta médica (art. 170.1 del TRLGSS).

b) Agotado el plazo de duración de 365 días indicado en el apartado anterior, la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social será la única competente para emitir el alta médica por curación, por mejoría que permita la reincorporación al trabajo, con propuesta de incapacidad permanente o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados por dicha

entidad gestora. De igual modo, la citada inspección médica será la única competente para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal producida, por la misma o similar patología, en los ciento ochenta días naturales posteriores a la citada alta médica.

La falta de alta médica, una vez agotado dicho plazo, supondrá que el trabajador se encuentra en la situación de prórroga de incapacidad temporal a que se refiere el artículo 169.1.a) por presumirse que, dentro del período subsiguiente de ciento ochenta días, aquel puede ser dado de alta médica por curación o mejoría.

La colaboración obligatoria en el pago de la prestación se mantendrá hasta que se notifique al interesado el alta médica por curación, por mejoría o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos, o hasta el último día del mes en que el Instituto Nacional de la Seguridad Social haya expedido el alta médica con propuesta de incapacidad permanente, o hasta que se cumpla el periodo máximo de quinientos cuarenta y cinco días, finalizando en todo caso en esta fecha.

Las empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social a las que hace referencia el artículo 102.1.a) mantendrán el pago a su cargo de la prestación hasta la fecha en que se notifique al interesado el alta médica o la resolución por la que

se extinga el derecho al subsidio, incluida, en su caso, la situación de prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal a que se refiere el artículo 174.5.

Frente al alta médica por curación, por mejoría o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos emitida por la inspección médica del Instituto

Nacional de la Seguridad Social una vez agotado el plazo de duración de los trescientos sesenta y cinco días, el artículo 170 del TRLGSS regula un procedimiento de disconformidad del interesado con el alta médica emitida.

Así el interesado en el plazo de 4 días naturales puede mostrar su disconformidad ante la Inspección Médica del Servicio Público de Salud. La Inspección Médica puede:

a) En el plazo máximo de 7 días naturales, discrepar del alta médica proponiendo la reconsideración del alta e indicando las razones en las que se basa. En este supuesto la entidad gestora (INSS) en los 7 días naturales siguientes deberá resolver notificándolo al interesado y a la inspección Médica. En la nueva resolución administrativa la entidad gestora puede o reconocer la prórroga o mantener el alta médica. En este último caso la IT se habrá prorrogado hasta la fecha de la resolución confirmatoria de la entidad gestora.

b) Confirmar la decisión del INSS c) No dar respuesta en los 11 días naturales siguientes.

Si la inspección médica del servicio público de salud se pronunciara confirmando la decisión de la Inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social o si no se produjera pronunciamiento alguno en los once días naturales siguientes a la fecha de la resolución, la mencionada alta médica adquirirá plenos efectos. Durante el período de tiempo transcurrido entre la fecha del alta médica y aquella en la que la misma adquiera plenos efectos se considerará prorrogada la situación de incapacidad temporal.

Durante la prórroga de la situación de incapacidad temporal se mantendrá la colaboración obligatoria en el pago de la prestación, así como la colaboración voluntaria, en su caso.

c) Supuesto en el que la IT deriva de un periodo de observación para el diagnóstico de enfermedad profesional, la duración máxima es de 180 días y podía ser prorrogado por 180 días más cuando así lo estime necesario el INSS, previa propuesta del equipo de valoración de incapacidades (art. 169.1 b) del

TRLGSS y art. 1.1 c) del Real Decreto

1300/1995, de 21 de julio).

• Recaídas

El artículo 169.3 del TRLGSS, dispone que, a efectos de determinar la duración máxima del subsidio y de su posible prórroga, se computaran los periodos de recaída y de observación en un mismo proceso. Se considerará que existe recaída en un mismo

proceso cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 170.1 del TRLGSS y, en el marco de las competencias atribuidas a los inspectores médicos adscritos al INSS para ejercer, respecto de los procesos de incapacidad temporal, las mismas competencias que la inspección de servicios sanitarios de la seguridad social u órgano equivalente del respectivo servicio público de salud, se incluye también la de considerar que existe recaída en un mismo proceso.

4.3. EXTINCIÓN DEL DERECHO

El artículo 174 del TRLGSS establece:

1. El derecho al subsidio se extinguirá:

- a) Por el transcurso del plazo máximo de 545 días naturales desde la baja médica.
- b) Por alta médica por curación o mejoría que permita al trabajador realizar su trabajo habitual.
- c) Por ser dado de alta el trabajador con o sin declaración de incapacidad permanente d) Por haber sido reconocido al beneficiario el derecho al percibo de la pensión de jubilación.
- e) Por la incomparecencia injustificada a cualquiera de las convocatorias para los exámenes y reconocimientos establecidos por los médicos adscritos al INSS o a la mutua colaboradora.
- f) Fallecimiento del beneficiario.

A efectos de determinar la duración del subsidio, se computarán los períodos de recaída en un mismo proceso.

Cuando, iniciado un expediente de incapacidad permanente antes de que hubieran transcurrido 545 días naturales de duración del subsidio de incapacidad temporal (365 días de duración + 180 de prórroga), se deniegue el derecho a la prestación de incapacidad permanente, el INSS a través de su inspección médica, será el único competente para emitir, dentro de los 180 días naturales posteriores a la resolución denegatoria, una nueva baja médica por la misma o similar patología. En estos casos se reanuda el proceso de incapacidad temporal hasta el cumplimiento de los 545 días, como máximo.

2. Cuando el derecho al subsidio se extinga por el transcurso del período de 545 días naturales, se ha de examinar necesariamente, en el plazo máximo de 90 días, el estado del incapacitado a efectos de su calificación, en el grado de incapacidad permanente que corresponda.

No obstante, en aquellos casos en los que, continuando la necesidad de tratamiento médico por la expectativa de recuperación o la mejora del estado del trabajador, con vistas a su reincorporación laboral, la situación clínica del interesado hiciera aconsejable demorar la citada calificación, ésta podrá retrasarse por el período preciso, sin que en ningún caso se puedan rebasar los 730 días naturales, sumados los de incapacidad temporal y los de prolongación de sus efectos. En estos supuestos, el artículo 7 del Real Decreto 1430/2009 exige resolución expresa del INSS, que ha de comunicarse

telemáticamente a la empresa, a propuesta del equipo de valoración de incapacidades (EVI), y previa audiencia de la mutua por 7 días hábiles (si la contingencia estuviera protegida con ella).

Durante los períodos de 90 días y de demora de la calificación, no subsiste la obligación de cotizar.

3. Extinguido el derecho a la prestación de incapacidad temporal por el transcurso del plazo de quinientos cuarenta y cinco días naturales de duración, con o sin declaración de incapacidad permanente, solo podrá generarse un nuevo derecho a la prestación de incapacidad temporal por la misma o similar patología, si media un período superior a ciento ochenta días naturales, a contar desde la resolución de la incapacidad permanente.

Este nuevo derecho se causará siempre que el trabajador reúna, en la fecha de la nueva baja médica, los requisitos exigidos para ser beneficiario del subsidio de incapacidad temporal derivado de enfermedad común o profesional, o de accidente, sea o no de trabajo. A estos efectos, para acreditar el período de cotización necesario para acceder al subsidio de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas a partir de la resolución de la incapacidad permanente.

No obstante, aun cuando se trate de la misma o similar patología y no hubiesen transcurrido ciento ochenta días naturales desde la denegación de la incapacidad permanente, podrá iniciarse un nuevo proceso de incapacidad temporal, por una sola vez, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social,

a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la situación de incapacidad permanente del trabajador, considere que el trabajador puede recuperar su capacidad laboral.

Para ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social acordará la baja a los exclusivos efectos de la prestación económica por incapacidad temporal.

4. El alta médica con propuesta de incapacidad permanente, cualquiera que sea el momento en el que sea expedida, extinguirá la situación de incapacidad temporal.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando la extinción se produjera por alta médica con propuesta de incapacidad permanente, o por el transcurso de los quinientos cuarenta y cinco días naturales, el trabajador estará en la situación de prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal hasta que se notifique la resolución en la que se califique la incapacidad permanente.

En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, cuando se reconozca la prestación de incapacidad permanente, sus efectos coincidirán con la fecha de la resolución de la entidad gestora por la que se reconozca, salvo que la misma sea superior a la que venía percibiendo el trabajador en concepto de prolongación de los efectos de la incapacidad temporal, en cuyo caso se retrotraerán aquellos efectos al día siguiente al de extinción de la incapacidad temporal.

En aquellos casos en los que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.1.n)

del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, la declaración de incapacidad permanente en los grados de total, absoluta o gran incapacidad no determine la extinción de la relación laboral, por llevar a cabo la empresa la adaptación razonable, necesaria y adecuada del puesto de trabajo a la nueva situación de incapacidad declarada o por haber destinado a otro puesto a la persona trabajadora, la prestación de incapacidad permanente se suspenderá durante el desempeño del mismo puesto de trabajo con adaptaciones u otro que resulte incompatible con la percepción de la pensión que corresponda, de acuerdo con el artículo 198.

En caso de extinción de la incapacidad temporal anterior al agotamiento de los quinientos cuarenta y cinco días naturales de duración de la misma sin que exista ulterior declaración de incapacidad permanente, subsistirá la obligación de cotizar mientras no se extinga la relación laboral o hasta la extinción del citado plazo de quinientos cuarenta y cinco días naturales, de producirse con posterioridad dicha declaración de inexistencia de incapacidad permanente.

4.4. PÉRDIDA O SUSPENSIÓN DEL DERECHO AL SUBSIDIO

1. El derecho al subsidio por incapacidad temporal podrá ser denegado, anulado o suspendido:

a) Cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación.

b) Cuando el beneficiario trabaje por cuenta propia o ajena.

2. También podrá ser suspendido el derecho al subsidio cuando, sin causa razonable, el beneficiario rechace o abandone el tratamiento que le fuere indicado.

3. La incomparecencia del beneficiario a cualquiera de las convocatorias realizadas por los médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para examen y reconocimiento médico producirá la suspensión cautelar del derecho, al objeto de comprobar si aquella fue o no justificada. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de suspensión del derecho y sus efectos.

(art.175 LGSS)

5. RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PRESTACIÓN

En la prestación de IT rige el principio de oficialidad, por lo que no es necesaria la solicitud por parte del beneficiario para percibir la prestación, sino que esta se debe pagar por el mero hecho del parte médico de baja. El reconocimiento corresponde a la entidad gestora, mutua colaboradora con la Seguridad Social, o empresa colaboradora voluntaria que cubra la contingencia.

En este punto es necesario hacer una breve referencia a las normas relativas a la determinación de la contingencia. Una vez emitido un parte de baja por contingencia común o profesional, se puede instar ante el INSS la revisión del carácter inicial de la contingencia. El procedimiento se establece en el artículo 6 del Real Decreto 1430/2009.

Dicho procedimiento se puede iniciar:

- a) De oficio, por propia iniciativa del INSS, o como consecuencia de petición motivada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del servicio público de salud competente para gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, o a propuesta del Instituto Social la Marina.
- b) A instancia del trabajador o su representante legal.
- c) A instancia de las mutuas o de las empresas colaboradoras, en aquellos asuntos que les afecten directamente.

2. El INSS comunica la iniciación del procedimiento al servicio público de salud competente, a la mutua o a la empresa colaboradora, según corresponda, cuando el procedimiento no se hubiera iniciado a su instancia y en aquellos asuntos que les afecten, para que, en el plazo improrrogable de 4 días hábiles, aporten los antecedentes relacionados con el caso. También se dará traslado al trabajador de la iniciación del procedimiento, cuando esta no hubiera sido a instancia suya, comunicándole que dispone de un plazo de 10 días hábiles para aportar la documentación y hacer las alegaciones.

3. Cuando por el servicio público de salud se hubiera emitido parte de baja por contingencias comunes, se iniciará el abono de la prestación de incapacidad temporal que por estas corresponda hasta la fecha de resolución del procedimiento, sin perjuicio de que cuando la resolución determine el carácter profesional de la contingencia, la mutua que la cubra deba abonar al interesado la diferencia que resulte a su favor, y reintegrar tanto a la entidad gestora, en su caso, la prestación abonada a su cargo, mediante la compensación de las cuantías que procedan, como al servicio público de salud el coste de la asistencia sanitaria prestada. Asimismo, cuando la contingencia profesional estuviera a cargo de la entidad gestora, esta abonará al interesado las diferencias que le correspondan.

De igual modo se procederá cuando la resolución determine el carácter común de la contingencia, modificando la anterior calificación como profesional y su protección hubiera sido dispensada por una mutua. Esta deberá ser reintegrada por la entidad gestora y el servicio público de salud de los gastos generados por las prestaciones económicas y asistenciales hasta la cuantía que corresponda a dichas prestaciones en consideración a su

carácter común. Asimismo, la mutua, cuando ambas contingencias fueran protegidas por la misma, realizará las correspondientes compensaciones en sus cuentas.

4. El equipo de valoración de incapacidades emitirá un informe preceptivo, que elevará al director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el que se pronunciará sobre la contingencia que ha originado el proceso de dicha incapacidad.

5. Emitido el informe del equipo de valoración de incapacidades, el director provincial competente del Instituto Nacional de la Seguridad Social dictará la resolución que corresponda, en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde la aportación de la documentación por las partes interesadas, o del agotamiento de los plazos fijados para ello en el apartado 2 de este artículo.

5.1. RESPONSABILIDAD DEL PAGO

1. En el supuesto de enfermedad común o accidente no laboral, el abono del subsidio entre los días 4 a 15 de baja en el trabajo, ambos inclusive, se atribuye al empresario.

A partir del día 16 de baja, la responsabilidad del abono compete al INSS o a la mutua, en su caso (art. 173 del TRLGSS), aun cuando la materialidad del pago se continúe llevando a cabo en concepto de pago delegado por el mismo empresario.

En la situación especial de incapacidad temporal por menstruación incapacitante secundaria y donación de órganos o tejidos para su trasplante previstas en el párrafo segundo y cuarto del artículo 169.1 a) el subsidio se abonará igualmente, a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes desde el mismo día de baja.

En la situación especial de incapacidad temporal por interrupción del embarazo prevista en el mismo párrafo segundo del artículo 169.1.a), así como en la situación especial de gestación desde el día primero de la semana trigésima novena de gestación, prevista en el párrafo tercero del mismo artículo, el subsidio se abonará igualmente, a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja.

El artículo 82 del TRLGSS, regula la gestión por las mutuas colaboradoras con la

Seguridad Social de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, y posibilita a los empresarios a optar por que la cobertura de la prestación económica por incapacidad laboral derivada de contingencias comunes se lleve a efecto por la misma mutua con la que

se hayan concertado las contingencias profesionales, según se desarrolla en los artículos 69 y siguientes del

Real Decreto 1993/1995. Corresponde a las mutuas la función de declaración del derecho a la prestación económica, así como las de denegación, suspensión, anulación y declaración de extinción del mismo, sin perjuicio del control sanitario de las altas y bajas médicas por parte de los servicios públicos de salud y de los efectos atribuidos a los partes médicos. Los actos serán motivados y se formalizarán por escrito, estando supeditada su eficacia a la notificación al beneficiario.

Asimismo, se notificarán al empresario en los supuestos en que el beneficiario mantenga relación laboral.

2. En el supuesto de AT/EP, la responsabilidad del pago de la prestación económica corresponde al INSS, o a una mutua colaboradora si la empresa ha concertado con ella el correspondiente convenio de asociación (art. 173 del TRLGSS), aun cuando la materialidad del pago se continúe llevando a cabo en concepto de pago delegado por el mismo empresario.

3. El artículo 102.1 a) TRLGSS prevé una forma de colaboración voluntaria asumiendo directamente el pago, a su cargo, de las prestaciones por incapacidad temporal derivada de AT/EP y las prestaciones de asistencia sanitaria y recuperación profesional.

5.2. PAGO DELEGADO O COLABORACIÓN OBLIGATORIA DE LAS EMPRESAS

Sin perjuicio de la responsabilidad en el pago del subsidio de IT, el acto material de dicho pago se efectuará directamente por la empresa como consecuencia de la colaboración obligatoria en la gestión de la Seguridad Social, con base en lo dispuesto en el número 2 del artículo 102 del TRLGSS y Orden ministerial de 25 de noviembre de 1966. Esta forma de pago se denomina <<Pago delegado>> del subsidio de IT.

El pago delegado se abonará por los mismos periodos que los salarios y se hará efectivo en las mismas fechas que estos.

El importe de las prestaciones abonadas en régimen de pago delegado será objeto de compensación en las liquidaciones de cuotas en los documentos de cotización cuando se hayan cumplido en plazo las obligaciones de los dos primeros apartados del artículo 29 del TRLGSS.

Del importe de las prestaciones abonadas en régimen de pago delegado que no se hubieren compensado en los documentos de cotización cumpliendo las obligaciones del mencionado artículo 29, el sujeto responsable que las hubiere pagado podrá resarcirse solicitando la devolución del mismo ante la entidad gestora o colaboradora correspondiente.

La colaboración obligatoria en el pago de la prestación se mantendrá hasta que se notifique al interesado el alta médica por curación, por mejoría o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos, o hasta el último día del mes en que el Instituto Nacional de la Seguridad Social haya expedido el alta médica con propuesta de incapacidad permanente, o hasta que se cumpla el periodo máximo de quinientos cuarenta y cinco días, finalizando en todo caso en esta fecha.

Las empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social a las que hace referencia el artículo 102.1.a) mantendrán el pago a su cargo de la prestación hasta

la fecha en que se notifique al interesado el alta médica o la resolución por la que se extinga el derecho al subsidio, incluida, en su caso, la situación de prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal a que se refiere el artículo 174.5.

(Art. 170.2 LGSS).

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrá suspender o dejar sin efecto la colaboración obligatoria cuando la empresa incumpla las obligaciones establecidas (art. 102 del TRLGSS).

No obstante, existen diversas situaciones en las que es posible que el pago no se efectúe directamente por la empresa:

a) Entidades y organismos excluidos del pago delegado.

b) Las empresas de menos de 10 trabajadores, cuando vengán satisfaciendo la prestación durante 6 meses, pueden solicitar la finalización del pago.

c) Cuando se incumpla la obligación por parte de la empresa. La entidad gestora o la mutua deberán satisfacer la prestación económica, poniéndolo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social (art. 19 de la Orden de 25 de noviembre de 1966).

d) Extinción de la relación laboral durante la situación de incapacidad temporal.

e) Cuando se haya optado por la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes con una mutua, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a instancias de la mutua, podrá acordar la suspensión temporal de la colaboración obligatoria, cuando se considere necesario para un mejor control de los procesos de incapacidad.

f) Incapacidad temporal de los jubilados parciales, que se abonara directamente por la entidad gestora o colaboradora.

6. EL CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL

En este epígrafe se analiza la gestión y el control médico de la IT, que como veremos admite la intervención de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y empresas colaboradoras en los 365 primeros días. A efectos del control de los procesos de IT, la norma (Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por

incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración) distingue entre los procesos de IT hasta el día 365 y a partir del día 365.

6.1. COMPETENCIAS

Desde su inicio hasta el cumplimiento del día 365, la competencia en materia de control de la situación de IT corresponde a las siguientes entidades:

- Servicio Público de Salud (SPS), para emitir partes de baja, confirmación y alta.
- INSS para emitir altas medicas a todos los efectos, así como para iniciar el expediente de incapacidad permanente.
- Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, para emitir partes de baja, confirmación y alta por accidente de trabajo o enfermedad profesional (AT y EP) y propuestas de alta por contingencias comunes.
- Empresas colaboradoras, para emitir partes de baja, confirmación y alta respecto de los trabajadores a su servicio, siempre que tengan asumidas las competencias en la gestión de la asistencia sanitaria y de la IT derivadas de AT y EP.

Agotado el plazo de los 365 días, el INSS será el único competente para:

- Determinar la iniciación de expediente de IP.
- Emitir el alta médica.
- Emitir nueva baja médica cuando se produzca en el plazo de 180 días naturales posteriores al alta médica por la misma o similar patología.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social ejercerá a través de su inspección médica las competencias previstas en el artículo 170, apartados 1, 2 y 3, y en el artículo 174, apartado 1 de la Ley general de la Seguridad Social, tanto respecto de los trabajadores incluidos en el régimen general como de los comprendidos en alguno de los regímenes especiales del sistema de la Seguridad Social.

6.2. GESTIÓN DE LAS BAJAS, CONFIRMACIÓN, INFORMES COMPLEMENTARIOS Y DE CONTROL Y ALTAS

6.2.1. Declaraciones medicas de baja y de confirmación de la baja en los procesos de incapacidad temporal

La emisión del parte médico de baja es el acto que origina la iniciación de las actuaciones conducentes al reconocimiento del derecho al subsidio por incapacidad temporal. La declaración de la baja médica, en los procesos de incapacidad temporal, cualquiera que sea la contingencia determinante, se formulará en el correspondiente parte médico de baja expedido por el médico del servicio público de salud que haya efectuado el reconocimiento del trabajador afectado.

En el caso de que la causa de la baja médica sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y el trabajador preste servicios en una empresa asociada, para la gestión de la prestación por tales contingencias, a una mutua colaboradora con la

Seguridad Social, en adelante, mutua, o se trate de un trabajador por cuenta propia adherido a una mutua para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de las mismas contingencias, o cuando se trate de trabajadores asegurados por su propia empresa, en virtud de la colaboración prevista en el artículo

102.1.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, los correspondientes partes de baja, de confirmación de la baja o de alta serán expedidos por los servicios médicos de la propia mutua o por los servicios médicos de la empresa colaboradora.

Todo parte médico de baja irá precedido de un reconocimiento médico del trabajador que permita la determinación objetiva de la incapacidad temporal para el trabajo habitual, a cuyo efecto el médico requerirá al trabajador los datos necesarios que contribuyan tanto a precisar la patología objeto de diagnóstico, como su posible incapacidad para realizar su trabajo.

El servicio público de salud, la mutua o empresa colaboradora, según cual sea la entidad facultada para emitir el parte de baja, remitirá por vía telemática al Instituto

Nacional de la Seguridad Social, de manera inmediata y en todo caso en el primer día hábil siguiente al de su expedición, los partes médicos de baja, confirmación y alta (art.

7.1 del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio).

Con el fin de que las actuaciones médicas cuenten con el mayor respaldo técnico se pondrá a disposición de los médicos a los que competan dichas actuaciones tablas de duración óptima tipificadas por los distintos procesos patológicos susceptibles de generar incapacidades, así como tablas sobre el grado de incidencia de aquellos procesos en las distintas actividades laborales.

Los partes de baja y de confirmación de la baja se extenderán en función del periodo de duración que estime el médico que los emite. A estos efectos se establecen cuatro grupos de procesos:

a) En los procesos de duración estimada inferior a 5 días naturales, el facultativo del servicio público de salud, o de la mutua, emitirá el parte de baja y el parte de alta en el mismo acto médico. Consignará en el parte la fecha del alta, que podrá ser la misma que la de la baja o cualquiera de los 3 días naturales siguientes a esta.

No obstante, la persona trabajadora podrá solicitar que se le realice un reconocimiento médico el día que se haya fijado como fecha de alta, y el facultativo podrá emitir el parte de confirmación de la baja si considerarse que la persona trabajadora no ha recuperado su capacidad laboral.

b) En los procesos de duración estimada de entre cinco y treinta días naturales,

el facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que, en ningún caso, excederá en más de siete días naturales a la fecha de baja inicial. En la fecha de revisión se extenderá el parte de alta o, en caso de permanecer la incapacidad, el parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de catorce días naturales entre sí.

c) En los procesos de duración estimada de entre treinta y uno y sesenta días naturales, el facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que, en ningún caso, excederá en más de siete días naturales a la fecha de baja inicial, expidiéndose entonces el parte de alta o, en su caso, el correspondiente parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de veintiocho días naturales entre sí.

d) En los procesos de duración estimada de sesenta y uno o más días naturales, el facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, emitirá el parte de baja, en el que fijará la fecha de la revisión médica prevista, la cual en ningún caso excederá en más de catorce días naturales a la fecha de baja inicial, expidiéndose entonces el parte de alta o, en su caso, el correspondiente parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de treinta y cinco días naturales entre sí.

En cualquiera de los procesos contemplados en este apartado, el facultativo del servicio público de salud, de la empresa colaboradora o de la mutua podrá fijar la correspondiente revisión médica en un período inferior al indicado en cada caso.

Siempre que se produzca una modificación o actualización del diagnóstico, se emitirá un parte de confirmación que recogerá la duración estimada por el médico que lo emite. Los siguientes partes de confirmación se expedirán en función de la nueva duración estimada.

En todo caso, el facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, expedirá el parte de alta cuando considere que el trabajador ha recuperado su capacidad laboral.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social transmitirá al Instituto Social de la Marina y a las mutuas, de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su recepción, los partes de baja y de confirmación de la baja por contingencia común relativos a los trabajadores respecto de los que gestionen la incapacidad temporal cada una de ellas

Art. 2 RD 625/2014

6.2.2. Normas relativas a la determinación de la contingencia causante de la incapacidad temporal.

1. El servicio público de salud, el Instituto Social de la Marina, las mutuas o las empresas colaboradoras, que hayan emitido el parte de baja, podrán instar, motivadamente, ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social la revisión de la consideración inicial de la contingencia, mediante el procedimiento regulado en el artículo 6 del Real Decreto

1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley

40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con la prestación de incapacidad temporal.

2. El facultativo de la empresa colaboradora o de la mutua que asista al trabajador podrá inicialmente, previo reconocimiento médico preceptivo y realización, en su caso, de las pruebas que correspondan, considerar que la patología causante es de carácter común y remitir al trabajador al servicio público de salud para su tratamiento, sin perjuicio de dispensarle la asistencia precisa en los casos de urgencia o de riesgo vital. A tal efecto entregará al trabajador un informe médico en el que describa la patología y señale su diagnóstico, el tratamiento dispensado y los motivos que justifican la determinación de la contingencia causante como común, al que acompañará los informes relativos a las pruebas que, en su caso, se hubieran realizado.

Si, a la vista del informe de la empresa colaboradora o de la mutua, el trabajador acude al servicio público de salud y el médico de este emite parte de baja por contingencia común, el beneficiario podrá formular reclamación con relación a la consideración otorgada a la contingencia ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que se sustanciará y resolverá aplicando el procedimiento regulado en el artículo 6 del Real

Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre.

Por su parte, el facultativo que emita el parte de baja podrá formular su discrepancia frente a la consideración de la contingencia que otorgó la empresa colaboradora o la mutua, en los términos establecidos en el artículo 6 mencionado en el párrafo anterior, sin perjuicio de que el parte médico produzca plenos efectos.

La resolución que se dicte establecerá el carácter común o profesional de la contingencia causante y el sujeto obligado al pago de las prestaciones derivadas de la misma y a la prestación de asistencia sanitaria, en su caso.

Art. 3 RD 625/2014

6.2.3. Informes complementarios y de control

1. En los procesos de incapacidad temporal cuya gestión corresponda al servicio público de salud y su duración prevista sea superior a 30 días naturales, el segundo parte de confirmación de la baja irá acompañado de un informe médico complementario expedido por el facultativo que haya extendido el parte anterior, en el que se recogerán

las dolencias padecidas por el trabajador, el tratamiento médico prescrito, las pruebas médicas en su caso realizadas, la evolución de las dolencias y su incidencia sobre la capacidad funcional del interesado. En los procesos inicialmente previstos con una duración inferior y que sobrepasen el periodo estimado, dicho informe médico complementario deberá acompañar al parte de confirmación de la baja que pueda emitirse, en su caso, una vez superados los 30 días naturales.

Los informes médicos complementarios se actualizarán, necesariamente, con cada dos partes de confirmación de baja posteriores.

2. En los procesos cuya gestión corresponda al servicio público de salud, trimestralmente, a contar desde la fecha de inicio de la baja médica, la inspección médica del servicio público de salud o el médico de atención primaria, bajo la supervisión de su inspección médica, expedirá un informe de control de la incapacidad en el que deberá pronunciarse expresamente sobre todos los extremos que justifiquen, desde el punto de vista médico, la necesidad de mantener el proceso de incapacidad temporal del trabajador.

3. Los informes médicos complementarios, los informes de control, sus actualizaciones y las pruebas médicas realizadas en el proceso de incapacidad temporal forman parte de este, por lo que tendrán acceso a los mismos los inspectores médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto Social de la Marina y los facultativos de las mutuas respecto de los procesos por contingencias comunes correspondientes a los trabajadores protegidos por las mismas, al objeto de que puedan desarrollar sus funciones.

Asimismo, exclusivamente los inspectores médicos del propio servicio público de salud y los inspectores médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, al Instituto Social de la Marina tendrán acceso, preferentemente por vía telemática, a la documentación clínica de atención primaria y especializada, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del TRLGSS.

Art. 4 RD 625/2014

6.2.4. Parte médico de alta durante los 365 primeros días

1. Los partes de alta médica en los procesos derivados de contingencias comunes se emitirán, tras el reconocimiento del trabajador, por el correspondiente facultativo del servicio público de salud. En todo caso, deberán contener la causa del alta médica, el código de diagnóstico definitivo y la fecha de la baja inicial.

Asimismo, los partes de alta médica podrán también ser extendidos por los inspectores médicos del servicio público de salud, del Instituto Nacional de la

Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, tras el reconocimiento médico del trabajador afectado.

El alta médica extinguirá el proceso de incapacidad temporal del trabajador con efectos laborales del día siguiente al de su emisión, sin perjuicio de que el referido servicio público, en su caso, siga prestando al trabajador la asistencia sanitaria que

considere conveniente. El alta médica determinará la obligación de que el trabajador se reincorpore a su puesto de trabajo el mismo día en que se produzcan sus efectos.

Los partes médicos de alta por contingencias comunes se comunicarán a las mutuas, en el caso de trabajadores protegidos por ellas, en la forma y plazo establecidos en el artículo 2.5, debiendo las mismas comunicar a la empresa la extinción del derecho, su causa y su fecha de efectos.

2. En los procesos originados por contingencias profesionales, el parte médico de alta se expedirá por el facultativo o inspector médico del servicio público de salud o por el inspector médico adscrito al Instituto Nacional de la Seguridad Social o al

Instituto Social de la Marina si el trabajador está protegido con una entidad gestora, o por el médico dependiente de la empresa colaboradora o de la mutua a la que corresponda la gestión del proceso,

siendo asimismo de aplicación las condiciones establecidas en el apartado anterior, y el alcance de sus efectos.

3. El médico del servicio público de salud o el servicio médico de la empresa colaboradora o de la mutua, cuando expidan el último parte médico de confirmación antes del agotamiento del plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días naturales, comunicarán al interesado en el acto de reconocimiento médico que, una vez agotado el plazo referido, el control del proceso pasa a la competencia del

Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la

Marina en los términos establecidos en el artículo 170.2 del texto refundido de la

Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Una vez que se cumpla el plazo indicado en el párrafo anterior, el servicio público de salud o el servicio médico de la empresa colaboradora o de la mutua dejarán de emitir partes de confirmación.

El servicio público de salud comunicará al Instituto Nacional de la Seguridad Social el agotamiento de los trescientos sesenta y cinco días naturales en situación de incapacidad temporal, de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente.

Art. 5 RD 625/2014

6.2.5. Propuestas de alta médica formuladas por las mutuas en los procesos derivados de contingencias comunes

1. En los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes cuya cobertura corresponda a una mutua, cuando ésta, a la vista de los partes médicos de baja o de confirmación de la baja, de los informes complementarios o de las actuaciones de control y seguimiento que desarrolle, considere que el trabajador puede no estar impedido para el trabajo, podrá formular, a través de los médicos adscritos a ella, propuestas motivadas de alta médica, a las que acompañará los informes y pruebas que, en su caso, se hubiesen realizado. Las mutuas comunicarán simultáneamente al trabajador afectado, para su conocimiento, que se ha enviado la propuesta de alta.

2. Las propuestas de alta de las mutuas se dirigirán a las unidades de la inspección médica del servicio público de salud, quienes las remitirán inmediatamente a los facultativos o servicios médicos a quienes corresponda la emisión de los partes médicos del proceso. Estos facultativos deberán pronunciarse bien confirmando la baja médica, bien admitiendo la propuesta, a través de la expedición del correspondiente parte de alta médica.

En el caso de que se confirme la baja, se consignará el diagnóstico, el tratamiento médico dispensado, las causas que justifican la discrepancia y se señalarán las atenciones y los controles médicos que se considere necesario realizar. La inspección médica trasladará a la mutua este informe junto con la actuación realizada en el plazo máximo de cinco días desde la recepción de la propuesta de alta.

En el caso de que la inspección médica del correspondiente servicio público de salud no reciba contestación de los facultativos o de los servicios médicos, o en caso de discrepar de la misma,

podrá acordar el alta médica, efectiva e inmediata. En todo caso, la inspección comunicará a la mutua, dentro del plazo de los cinco días siguientes a la fecha de recepción de la propuesta de alta, la actuación realizada junto con los informes que el facultativo hubiera remitido.

3. Cuando la propuesta de alta formulada por una mutua no fuese resuelta y notificada en el plazo de cinco días establecido en el apartado anterior, la mutua podrá solicitar el alta al Instituto Nacional de la

Seguridad Social o, en su caso, al Instituto Social de la Marina, de acuerdo con las competencias previstas en el artículo 170.1 y en el apartado 4 de la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

La entidad gestora resolverá en el plazo de cuatro días siguientes a su recepción, efectuando las comunicaciones previstas en el artículo 7.4.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social y, en su caso, el Instituto Social de la

Marina, realizarán el seguimiento del comportamiento del nuevo procedimiento de gestión y control de los procesos por incapacidad temporal. Asimismo, ambas entidades realizarán el seguimiento del grado de motivación clínica de las propuestas de alta de las mutuas y de respuesta de la inspección médica de los servicios públicos de salud o del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, así como el grado de cumplimiento de los plazos de las distintas entidades en lo que se refiere a las propuestas de alta. En caso de que se detectasen retrasos significativos, se propondrán medidas adicionales que aseguren que el procedimiento se desarrolle con el necesario grado de celeridad.

Art. 6 RD 625/2014

6.2.6. Tramitación de los partes médicos y expedición de altas médicas por el

Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto Social de la

Marina.

1. El facultativo que expida el parte médico de baja, confirmación o alta entregará a la persona trabajadora una copia de este.

El servicio público de salud o, en su caso, la mutua o la empresa colaboradora remitirá los datos contenidos en los partes médicos de baja, confirmación y alta al

Instituto Nacional de la Seguridad Social, por vía telemática, de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su expedición.

2. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, a su vez, comunicará a las empresas los datos identificativos de carácter meramente administrativo relativos a los partes médicos de baja, confirmación y alta emitidos por los facultativos del servicio público de salud o de la mutua, referidos a sus personas trabajadoras, como máximo, en el primer día hábil siguiente al de su recepción en dicho Instituto, para su conocimiento y cumplimiento, en su caso, de lo previsto en el párrafo siguiente.

Las empresas tienen la obligación de transmitir al Instituto Nacional de la Seguridad

Social a través del sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED), con carácter inmediato y, en todo caso, en el plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación de la baja médica, los datos que se determinen mediante orden ministerial. La citada transmisión no será obligatoria cuando la persona trabajadora pertenezca a algún colectivo respecto del cual la empresa o empleador no tenga obligación de incorporarse al sistema RED.

El incumplimiento de la citada obligación podrá constituir, en su caso, una infracción de las tipificadas en el artículo 21.4 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y

Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social dará el trámite que corresponda a los partes médicos y a los datos comunicados por las empresas que vayan destinados a él mismo y, a su vez, también

mediante los medios informáticos previstos en el artículo

2.5, distribuirá y reenviará de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su recepción, los datos destinados al Instituto Social de la Marina y a las mutuas, según la entidad a quien corresponda la gestión de la prestación.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social facilitará a la Tesorería General de la

Seguridad Social, siempre que se precise, los datos de las personas trabajadoras que se encuentran en situación de incapacidad temporal con o sin derecho a prestación económica durante cada período de liquidación de cuotas, con el fin de que dicho servicio común lleve a cabo las actuaciones necesarias para que en la liquidación de cuotas de la Seguridad Social se compensen, en su caso, las cantidades satisfechas a las personas trabajadoras en el pago por delegación de dicha prestación. Esta comunicación entre entidades será necesaria, en todo caso, para que la Tesorería General de la

Seguridad Social aplique las citadas compensaciones en la liquidación de cuotas.

Cuando el empresario hubiese abonado a una persona trabajadora una prestación de incapacidad temporal en pago delegado, sin haberse compensado dicho importe mediante su deducción de las liquidaciones para el ingreso de las cuotas de la Seguridad

Social, podrá solicitar ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ante el Instituto

Social de la Marina o ante la mutua, según cuál sea la entidad competente para la gestión de la prestación, el reintegro de las cantidades abonadas a la persona trabajadora por tal concepto y no deducidas.

4. Cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 170.1 y en el apartado 4 de la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad

Social, el parte médico de alta sea expedido por el inspector médico del Instituto

Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, estas entidades trasladarán los datos contenidos en el parte de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de dicha expedición, al correspondiente servicio público de salud para su conocimiento y también a la mutua, en el caso de personas trabajadoras protegidas por la misma, con la finalidad de que esta dicte acuerdo declarando extinguido el derecho por causa del alta, sus motivos y efectos, y notifique el acuerdo a la empresa. Asimismo, el inspector médico entregará una copia del parte a la persona trabajadora, para su conocimiento, expresándole la obligación de incorporarse al trabajo el día siguiente al de la expedición.

La entidad gestora comunicará a la empresa, para su conocimiento, los datos meramente administrativos de los partes de alta médica de sus personas trabajadoras, como máximo, en el primer día hábil siguiente al de su expedición.

5. Cuando en un proceso de incapacidad temporal se haya expedido el parte médico de alta por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, por el Instituto

Social de la Marina, a través de los inspectores médicos de dichas entidades, durante los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha en que se expidió el alta, serán estas entidades las únicas competentes, a través de sus propios médicos, para emitir una nueva baja médica por la misma o similar patología.

Art. 7 RD 625/2014

6.2.7. Seguimiento y control de la prestación económica y de las situaciones de incapacidad temporal.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, en su caso, y las mutuas, a través de su personal médico y personal no sanitario, ejercerán el control y seguimiento de la prestación económica de la incapacidad temporal objeto de gestión, pudiendo realizar a tal efecto aquellas actividades que tengan por objeto comprobar el mantenimiento de los hechos y de la situación que originaron el derecho al subsidio, a partir del momento en que se expida el parte médico de baja, sin perjuicio de las competencias que corresponden a los servicios públicos de salud en materia sanitaria.

Los actos de comprobación de la incapacidad temporal que lleven a cabo los médicos del respectivo servicio público de salud, los inspectores médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, así como los médicos dependientes de las mutuas deberán basarse tanto en los datos que fundamenten los partes médicos de baja y de confirmación de la baja, como en los derivados de los reconocimientos médicos e informes realizados en el proceso. A tal efecto, aquellos podrán acceder a los informes médicos, pruebas y diagnósticos relativos a las situaciones de incapacidad temporal, a fin de ejercitar sus respectivas funciones.

Asimismo, la Intervención General de la Seguridad Social, en sus funciones de control interno, podrá acceder a los datos relativos a las situaciones de incapacidad temporal que sean estrictamente necesarios para poder ejercer dichas funciones.

En todo caso, los inspectores médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, para el ejercicio de sus competencias, tendrán acceso, preferentemente por vía telemática, a la documentación clínica de atención primaria y especializada de los trabajadores del sistema de la Seguridad Social, incluida la documentación clínica de los trabajadores protegidos frente a las contingencias profesionales con las mutuas, en los términos establecidos en la disposición adicional cuadragésima de la Ley General de la Seguridad Social.

2. Con el fin de que las actuaciones médicas a las que se refiere este artículo cuenten con el mayor respaldo técnico, a los efectos indicados en el artículo 2.3, se pondrá a disposición de los médicos a los que competan dichas actuaciones tablas de duraciones óptimas, tipificadas para los distintos procesos patológicos susceptibles de generar incapacidades, así como tablas sobre el grado de incidencia de dichos procesos en las diversas ocupaciones laborales, a que se refiere el artículo 2.2.

3. El tratamiento de los datos de los trabajadores afectados así como el acceso a los mismos quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en sus disposiciones de desarrollo.

Los datos únicamente podrán ser utilizados con la finalidad del control de los procesos de incapacidad y control interno, sin que puedan ser empleados para finalidades distintas. En ningún caso podrán ser utilizados con fines discriminatorios o en perjuicio del trabajador.

El personal no sanitario al que se refiere el apartado primero de este artículo únicamente accederá a los datos de los trabajadores afectados que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades establecidas en el mismo.

Deberán implantarse sobre los datos de carácter personal a los que se refiere este artículo las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente en materia de protección de datos. En todo caso, se procederá al cifrado de los datos mediante su codificado.

Los datos tendrán carácter confidencial siendo de aplicación a quienes accedan a los mismos las normas de protección de datos relacionadas con el deber de secreto así como las reguladoras del secreto profesional.

6.2.8. Requerimientos a los trabajadores para reconocimiento médico.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, podrá disponer que los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal sean reconocidos por los inspectores médicos de dichas entidades gestoras.

Igual facultad corresponderá a las mutuas, respecto de los beneficiarios de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes incluidos en su ámbito de gestión, para que sean reconocidos por los médicos dependientes de las mismas.

2. Los reconocimientos a que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo respetando, en todo caso, el derecho a la intimidad y a la dignidad de los trabajadores.

En todo caso serán de aplicación las garantías establecidas en el artículo 8 en relación con el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de los trabajadores y la confidencialidad de la información objeto de tratamiento. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto para las historias clínicas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

3. La citación a reconocimiento médico a que se refiere este artículo habrá de comunicarse al trabajador con una antelación mínima de cuatro días hábiles.

En dicha citación se le informará de que en caso de no acudir al reconocimiento, se procederá a suspender cautelarmente la prestación económica, y que si la falta de personación no queda justificada en el plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha fijada para el reconocimiento, se procederá a la extinción del derecho al subsidio.

Si el trabajador justificara, antes de la fecha fijada para el reconocimiento médico o en ese mismo día, las razones que le impiden comparecer al mismo, la entidad gestora o mutua, podrá fijar una fecha posterior para su realización, comunicándolo al interesado con la antelación mínima ya indicada.

4. Cuando el trabajador que hubiera sido citado a reconocimiento por la entidad gestora no se personara en la fecha fijada, el director provincial correspondiente dictará resolución, que será inmediatamente comunicada al interesado, disponiendo la suspensión cautelar del subsidio desde el día siguiente al fijado para el reconocimiento, e indicándole que dispone de un plazo de diez días hábiles, a partir de la fecha en que se produjo la incomparecencia, para justificar la misma.

Cuando el trabajador que hubiera sido citado a reconocimiento médico por una mutua no acuda al mismo en la fecha fijada, aquella acordará la suspensión cautelar del subsidio desde el día siguiente al fijado para el reconocimiento, lo que comunicará inmediatamente al interesado indicándole que dispone de un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que se produjo la incomparecencia, para justificarla.

La entidad gestora o la mutua comunicará la suspensión acordada por vía telemática a la empresa y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

5. Si el trabajador justifica su incomparecencia dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que estaba citado a reconocimiento médico, el director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina dictará nueva resolución, o la mutua nuevo acuerdo, dejando sin efecto la suspensión cautelar, y procederá a rehabilitar el pago de la prestación con efectos desde la fecha en que quedó suspendida. En estos casos la entidad gestora o mutua, en el plazo de quince días

siguientes a la fecha en que se dicte la resolución o acuerdo, pagará directamente al trabajador el subsidio correspondiente al período de suspensión.

Asimismo, comunicará a la empresa y a la Tesorería General de la Seguridad Social la resolución o acuerdo por la que la suspensión queda sin efecto, informando de la fecha a partir de la cual procede reponer el pago delegado por parte de la empresa.

Se entenderá que la incomparecencia fue justificada cuando el trabajador aporte informe emitido por el médico del servicio público de salud que le dispense la asistencia sanitaria, en el que se señale que la personación era desaconsejable conforme a la situación clínica del paciente; cuando la cita se hubiera realizado con un plazo previo inferior a cuatro días hábiles, o bien cuando el beneficiario acredite la imposibilidad de su asistencia por otra causa suficiente.

6. Transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que estaba citado a reconocimiento médico por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto

Social de la Marina, sin que el trabajador hubiera aportado justificación suficiente de su incomparecencia, el director provincial correspondiente dictará resolución declarando la extinción del derecho a la prestación económica con efectos desde el día en que hubiera sido efectiva la suspensión. Dicha resolución se notificará al interesado. La entidad gestora comunicará la extinción acordada, por vía telemática, al servicio público de salud, a la empresa y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

El inspector médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina podrá expedir el alta médica por incomparecencia en el ejercicio de las competencias previstas en la disposición adicional quincuagésima segunda de la Ley

General de la Seguridad Social.

7. Transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que estaba citado a reconocimiento médico por la mutua correspondiente, sin que el trabajador hubiera aportado justificación suficiente de su incomparecencia, la mutua acordará la extinción del derecho a la prestación económica con efectos desde el día en que hubiera sido efectiva la suspensión. Dicho acuerdo se notificará al interesado. La mutua comunicará la extinción acordada, por vía telemática, al servicio público de salud, a la empresa y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Art. 9 RD 625/2014

I INFOGRAFÍAS Y ESQUEMAS DEL TEMA

I INCAPACIDAD TEMPORAL (IT) – DURACIÓN Y PRESTACIÓN

Días 1-3	Días 4-15	Días 16-20	Días 21-365	+ 365 días (prórroga)
Sin subsidio (a cargo empresa en AT/EP desde d.1)	60% BR a cargo del empresario	60% BR a cargo de Mutua/INSS	75% BR a cargo de Mutua/INSS	75% BR hasta 545 días (IP o alta)

365 días Duración máxima IT (CC)	+180 días Prórroga excepcional	545 días Máximo total IT + prórroga	730 días Máximo absoluto (IT+efectos)
--	--	---	--

I CONTINGENCIAS COMUNES (CC)

- Enfermedad común y accidente no laboral
- Periodo carencia: 180 días en últimos 5 años
- Desde día 4 → subsidio a cargo empresa (d.4-15)
- Base Reguladora: BC mes anterior ÷ 30
- Gestiona: Mutua colaboradora o INSS

I AT y ENFERMEDADES PROFESIONALES (EP)

- No requiere periodo de carencia
- Desde el día siguiente al AT/EP
- Empresa paga todos los días (a través Mutua)
- Base Reguladora incluye horas extraordinarias
- Recargo 30-50% si hay infracción prevención

II ERRORES FRECUENTES EN EXAMEN

Error: El subsidio IT se paga desde el primer día de baja en contingencias comunes **Correcto:** En CC no hay subsidio los 3 primeros días; desde el día 4 lo paga la empresa

Error: El 75% de la BR se aplica desde el primer día de IT
Correcto: El 75% se aplica desde el día 21; del día 4 al 20 es el 60%

PREGUNTAS TIPO TEST · TEMA 8 (I)

1. En la IT por contingencias comunes, ¿desde qué día empieza a devengarse el subsidio?

a) Desde el día 1 de baja

b) Desde el día 2

c) Desde el día 4

d) Desde el día 16

En CC, los 3 primeros días no se percibe subsidio. Desde el día 4, el subsidio lo abona la empresa como pago delegado (días 4-15).

2. ¿Qué porcentaje de la Base Reguladora corresponde a la IT a partir del día 21?

a) 60%

b) 70%

c) 75%

d) 100%

Del día 4 al 20 → 60% BR. A partir del día 21 → 75% BR. En AT/EP, el 75% se aplica desde el día siguiente al accidente.

3. ¿Cuál es la duración máxima de la IT incluyendo la prórroga excepcional?

a) 365 días naturales

b) 455 días naturales

c) 545 días naturales

d) 730 días naturales

La IT dura 365 días + prórroga de 180 = 545 días máximo. A los 365 días el INSS asume el control del proceso.

4. En la IT por AT, ¿se requiere periodo mínimo de cotización?

a) Sí, 180 días en los últimos 5 años

b) Sí, 360 días en toda la vida laboral

c) No se requiere ninguna carencia

d) Solo si es el primer AT del trabajador

AT y EP son contingencias profesionales: NO requieren periodo de carencia. El subsidio nace desde el día siguiente al accidente.

5. ¿Quién asume el pago del subsidio IT por CC del día 16 en adelante?

a) La empresa siempre

b) El trabajador directamente

c) La Mutua colaboradora o el INSS

d) La TGSS

Del día 16 en adelante, la responsabilidad del pago pasa a la Mutua o al INSS (aunque materialmente lo siga abonando la empresa como pago delegado).

6. ¿Cómo se calcula la Base Reguladora en la IT por contingencias comunes?

a) Media de los últimos 12 meses cotizados

b) BC del mes anterior a la baja dividida entre 30

c) BC anual dividida entre 365

d) Media de las últimas 180 bases diarias

La BR (CC) = Base de Cotización del mes anterior a la baja ÷ número de días de ese mes. Para AT/EP, la BR incluye además las horas extraordinarias.

FICHA RESUMEN · TEMA 8 (I)

II DURACIÓN IT	
Duración máxima CC/ANL: 365 días naturales	
› Prórroga excepcional: +180 días (total 545)	
› Máximo absoluto con efectos: 730 días	
› AT/EP: misma duración (365+180)	
A los 365 días → INSS asume el control	

I BASE REGULADORA (BR)	
CC/ANL: BC mes anterior ÷ nº días del mes	
› AT/EP: BC día × 365 ÷ 365 (incluye horas extra)	
› Trabajadores a tiempo parcial: fórmula específica	
› Sistema especial agrario: base diaria	

I CUANTÍA DEL SUBSIDIO	
Días 1-3 CC: sin subsidio (salvo convenio)	
	› Días 4-15 CC: 60% BR → empresa (pago delegado)
› Días 16-20 CC: 60% BR → Mutua/INSS	
› Días 21-365 CC: 75% BR → Mutua/INSS	
AT/EP: 75% BR desde día siguiente	

I PERIODOS DE CARENCIA	
CC: 180 días cotizados en últimos 5 años	
› AT y EP: NO requieren carencia	
› ANL: 180 días en últimos 5 años	
› Maternidad (nacimiento): 180 días en 7 años	
› Menos de 21 años: carencia reducida	